

Результаты хирургического лечения рака поджелудочной железы

Жумакаев М.Д., Мусулманбеков К.Ж.

Карагандинская государственная медицинская академия.

Карагандинский областной онкологический центр.

УДК: 616.37-006.6-089:615.036

Ұйқы безінің қатерлі ісігіне шалдыққан науқастарды оташылдық жолмен емдеу, ұзақ өмір сүрудің жалғыз сенімді жолы болып тұр. Оташылдық емнен кейінгі ең жиі кездесетін асқынуы – диарея, ішектің денервациясының себебінен болып, ол бірнеше айға дейін жалғасып, науқастың жағдайын төмендетеді. Көптеген мақалаларда осы туралы көп жазылып, бұл патологияны емдеу әлі кезге шейін оташылдық емдеудің жолы әлі де жетілдіруді талап етеді.

Мақсаты – оташылдық емдеудің тікелей нәтижелерін жақсарту.

Ұйқы безінің басы, денесі және құйрығының қатерлі ісігіне шалдыққан 28 науқасқа оташылдық ем жүргізілді. Жасалған зерттеулерді сараптай отырып, оташылдық емнің көрсеткішін дұрыс реттеуі мен оташылдық үрдісін жетілдіру, оташылдық емнен кейінгі асқынуларды азайтуы бірталай жетістікке әкеледі. Өлімге әкеліп соғатын асқынулардың бірі панкреатоеюнальды жалғамның жарамсыздығы. Панкреатоеюнальды жалғамның ұсынылған инвагинациялық тәсілі осы асқынуларды біршама азайтуға мүмкіндік береді.

Результаты хирургического лечения рака поджелудочной железы

Жумакаев М.Д., Мусулманбеков К.Ж.

Хирургическое лечение является единственной надеждой на длительную выживаемость больных раком поджелудочной железы. Самым частым послеоперационным осложнением является диарея, обусловленная денервацией кишечника, который может продолжаться несколько месяцев, что ухудшает качество жизни больных. Многочисленные публикации говорят о том, что лечение данной патологии требует дальнейшего совершенствования и поиска новых методов хирургической операции.

Цель – улучшение непосредственных результатов

По поводу рака поджелудочной железы выполнено хирургическое лечение 28 больным, из них 19 произведено панкреатодуоденальная резекция и 9 резекция тела и хвоста поджелудочной железы.

С целью профилактики недостаточности панкреатоеюнального анастомоза использован новый инвагинационный метод панкреатоеюнального анастомоза, что дало возможность снизить количество этого грозного осложнения.

Введение

Единственной надеждой на длительную выживаемость для больных раком поджелудочной железы представляется, по общему мнению, хирургическое лечение, однако возможность его, вследствие поздней диагностики, склонности опухоли к местной распространенности и отдаленному

Results of pancreatic cancer surgical treatment

Zhumakaev M. D., Musulmanbekov K. Z.

Surgical treatment is unique hope of long survival rate for pancreatic cancer patients. The most frequent postoperative complication is the diarrhea caused by denervation of intestines which can proceed some months that worsens patient's life quality. Numerous publications say that treatment of the given pathology demands the further perfection and search of new methods surgical operation.

The purpose of investigation was improvement direct results of surgical treatment.

28 patients with cancer of head, body and tail of pancreas were operated.

The conducted analysis of research shows that at correct development of indications to surgical intervention, improvement of technique of execution of operation it is possible to achieve certain success in decrease postoperative mortality. One of principal causes of mortalities is insufficiency of seams pancreatojejunal anastomosis. Developed pancreatojejunal invaginate anastomosis gives the chance to reduce quantity of such complication.

хирургического лечения.

Прооперировано 28 больных раком головки, тела и хвоста поджелудочной железы.

Проведенный анализ исследования показывает, что при правильной выработке показаний к хирургическому вмешательству, усовершенствовании техники исполнения операции можно достичь определенного успеха в снижении послеоперационной летальности. Одним из основных причин летальности является недостаточность швов панкреатоеюнального анастомоза. Разработанный инвагинационный панкреатоеюнальный анастомоз дает возможность уменьшить количество такого осложнения.

метастазированию ограничены [1].

История хирургии рака поджелудочной железы (РПЖ) известна чередованием успехов и разочарований, триумфов и забвения имен и методов.

Поворотным пунктом в истории РПЖ многие считают 1935 год. Описанная в этом году А. Whipple операция открыла новую эру в лечении РПЖ выполненного им в два этапа [1]. Автор к 1945 году осуществил 19 одноэтапных панкреатодуоденальных резекций (ПДР), стал анастомозировать культю поджелудочной железы (ПЖ) с тощей кишкой. Летальность при этом достигало 31 % [2].

В Харьковском НИИ клинической и экспериментальной хирургии, где наиболее активно осваивалась эта сфера хирургии произведены 103 ПДР с летальностью 29,5 %. В последующие 8 лет на 127 ПДР летальность удалось со-

кратить до 12 % [4].

А.С. Макоха привел результаты лечения 270 больных раком панкреатодуоденальной зоны, из них у 109 произведены ПДР, у 80 расширенные радикальные, у 24 экономные. Общая послеоперационная летальность составила 26,6 % [3].

Несмотря на постоянное совершенствование техники хирургического лечения РПЖ послеоперационные осложнения и связанная с этим летальность остается высокой и колеблется от 12 до 32 % [4, 5, 6, 7, 8, 10]. Однако, за последние годы отдельные авторы сообщают о летальности ниже 10 % за счет улучшения предоперационной подготовки, усовершенствования техники выполнения операции и повышения работы реанимационной службы (11, 12, 13).

По данным Т.Т. White с соавт [14], А.В. Гаврилина и А.В. Вукалова [15] наиболее частым послеоперационным осложнением является панкреатит встречающийся в 20-50 %. По их мнению они часто являются фактором риска развития несостоятельности ПЕА и одной из ведущих причин послеоперационной летальности.

Поиски профилактики недостаточности ПЕА привели к появлению множественных способов формирования анастомозов между поджелудочной железой, тонкой кишкой и желудком.

В последние десятилетия среди хирургов получило широкое применение формирование ПЕА и других анастомозов на единой петле тощей кишки.

Результаты стандартной ПДР во многих клиниках долгое время оставались неудовлетворительными. По проведенным обобщениям мировых данных из 4100 пациентов лишь 144 (3,5 %) пережили 5 лет [8].

Констатируя бесперспективность чисто хирургического лечения в виде стандартной ПДР, хирурги приступили к поиску более обширных, более радикальных методов хирургического лечения. Так J.G. Fortner [16] в США и позднее O. Ishikawa с соавт. [17] в Японии разработали расширенную ПДР. J.G. Fortner добился отдаленной выживаемости в 20 %, при послеоперационной летальности 23 %.

По данным В.А. Кубышкина [18] при расширенной ПДР удлинняется продолжительность операции от 290 до 640 минут, а также интраоперационная кровопотеря достигает от 1500 до 5000 мл., что является причиной высокого послеоперационного осложнения у 88-92 % больных. Самым частым послеоперационным осложнением является диарея обусловленная денервацией кишечника, который может продолжаться несколько месяцев, что существенно ухудшает качество жизни больных.

Не улучшилась выживаемость от выполнения сверх радикальных операций. Оказалось, что у больных с опухолями меньше 2 см. как после стандартной, так и после расширенной ПДР пятилетняя выживаемость составила 27 %, средняя продолжительность жизни также одинакова – 18 месяцев [19].

Таким образом, после долгих лет эволюции хирургии РПЖ говорить о хирургической победе над этим заболеванием отнюдь не приходится и лечение данной патологии требует дальнейшего совершенствования и поиска новых методов хирургической операции.

Цель

исследования улучшение непосредственного результата хирургического лечения рака поджелудочной железы.

Работа основана на клиническом материале Карагандинского областного онкологического центра за 11 лет (1995-2005 г.г.).

Материал и методы исследований

В основу работы положен анализ истории болезни 29 боль-

ных подвернутых хирургическому методу лечения по поводу рака головки, тела и хвоста поджелудочной железы.

Распределение больных по возрасту следующие: до 30 лет – 1, 30-39 лет – 2, 40-49 лет – 3, 50-59 лет – 9, 60-69 лет – 9, 70 лет и старше – 5 больных. Самому молодому 25, старшему 77 лет. Мужчин – 13, женщин – 16.

Из представленных данных видно, что среди оперированных наибольшую группу составили больные старше 50 лет.

Установлено, что в 10 случаях опухоль локализовалась в головке, в 6 – в фатеровом соске, в одном – в крючковидном отростке и в двух случаях опухоль дистального отдела желудка и восходящего отдела ободочной кишки с прорастанием 12-перстную кишку и головки поджелудочной железы. В 9 случаях опухоль в области тела и хвоста поджелудочной железы.

По стадиям процесса больные распределены следующим образом: 2 стадия – 11 (35,7 %), 3 стадия – 18 (64,3 %). Все больные (9) с локализацией опухоли в области тела и хвоста поджелудочной железы оперирован в 3 стадии заболевания.

В оценке стадии заболевания использована классификация злокачественных опухолей Международного противоракового Союза (1998 г.).

Среди оперированных встречались следующие сопутствующие заболевания:

1. Хронический пиелонефрит, вторичная артериальная гипертония – 5.
2. ИБС, аортакордиосклероз – 4.
3. ИБС, предсердная экстрасистолия, левосторонний гемипарез – 1.
4. Сахарный диабет, тип II, ИБС, аортакордиосклероз, пиелонефрит – 3.
5. Экссудативный плеврит – 2.

Таким образом, среди оперированных 15 (51,7 %) больных имели различного характера сопутствующие заболевания.

Больным произведены следующего объема операции:

При локализации опухоли в области тела и хвоста 9 больным произведена корпорокAUDАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ СО СПЛЕНЭКТОМИЕЙ.

С локализацией опухоли в области головки поджелудочной железы и фатерова соска 17 больным произведена панкреатодуоденальная резекция.

Двум больным произведена комбинированная панкреатодуоденальная резекция при прорастании опухоли соседних органов в головку поджелудочной железы, это опухоль печеночного угла ободочной кишки и опухоль дистального отдела желудка.

Ниже приводим выписки из истории двух больных подвергнутых комбинированной ПДР.

Пример 1.

Больная 3-о В.Т. 59 лет. История болезни № 3790, поступила 18.08.1999г. с жалобами на боли в правом подреберье и незаживающий свищ передней брюшной стенки.

Больной 14.01.99 г. в областной клинической больнице по поводу неоперабельного рака печеночного угла ободочной кишки наложен обходной илеотрансферзоанастомоз.

У больной имеется рана передней брюшной стенки размером 8 х 6 см., дном раны является петля кишечника с грануляционной тканью.

Установлен диагноз опухоль печеночного угла ободочной кишки T₄ N M₀, состояние после наложения илеотрансферзоанастомоза, послеоперационная грыжа брюшной стенки с эвентерацией.

Сопутствующее заболевание: ожирение II ст., варикозное расширение вен нижних конечностей.

После интенсивной подготовки, больная в удовлетворительном состоянии 18.08.1999 г. была взята на операцию. Иссечением края грануляционной раны произведена верхне

– срединная лапаротомия, острым путем рассечены множественный спаечный процесс. Ревизией обнаружена опухоль печеночного угла ободочной кишки с захватом илеотрансферзоанастомоза. С целью определения операбельности опухоли произведена мобилизация двенадцатиперстной кишки по Кохеру. При этом опухоль распалась с вскрытием просвета вертикальной части 12-перстной кишки за счет прорастания опухоли.

Дальнейшая ревизия показала, что опухоль прорастает крючковидный отросток и головку поджелудочной железы.

Произведена мобилизация правой половины ободочной кишки с правосторонней гемиколонэктомией и резекцией правой половины поперечной ободочной кишки с захватом илеотрансферзоанастомоза. По методу клиники наложен новый инвагинационный илеотрансферзоанастомоз в конец.

Произведена панкреатодуоденальная резекция с наложением инвагинационного панкреатоеюнального анастомоза по методу клиники. Операция завершена ликвидацией грыжи брюшной стенки. Послеоперационный период протекал без осложнений, выписана в удовлетворительном состоянии 30.09.1999 г.

Пример 2.

Больная 3-я Е.К. 52 года. История болезни № 5065 поступила во II хирургическое отделение 23.09.2002 г. с жалобами на боль в эпигастральной области, слабость и тошноту. Больна в течение 3* месяцев.

Состояние больной удовлетворительное со стороны сердечно-сосудистой и легких патологии не обнаружено. АД 110/80. пульс 74 уд. в 1', живот мягкий болезненный в эпигастральной области.

На R-скопии от 24.09.02 г. в антральном отделе желудка определяется округлой формы дефект наполнения с четкими неравными контурами размером 3х5 см.

Заключение: рак антрального отдела желудка.

Фиброгастроскопия от 23.09.02 г. в антральном отделе желудка обнаружена опухоль размером 4х5 см. смешанного характера роста. Взята биопсия.

Диагноз: рак антрального отдела желудка.

На УЗИ от 24.09.02 г. По ходу v. cavae inferior локализуется солидное образование размером 7 см., который в едином конгломерате с утолщенной стенкой малой кривизны желудка. Заключение: метастатический конгломерат опухоли брюшной полости.

С диагнозом рак антрального отдела желудка с метастазами в л/узлы ($T_3N_xM_0$) больная 30.09.02 г. взята на операцию. Произведена верхнесрединная лапаротомия. При ревизии обнаружена опухоль антрального отдела желудка размерами 10х15 см., прорастающая головку поджелудочной железы на протяжении 3х4 см.

Других изменений и метастазов в лимфоузлы не обнаружены. Решено произвести радикальную комбинированную операцию. Произведена субтотальная резекция желудка, резекция головки поджелудочной железы. При формировании панкреатоеюнального анастомоза использована новая методика разработанная в клинике. Дополнительно произведена лимфадиссекция на уровне D_2 .

Гистологическое заключение от 08.10.02 г. № 16061-77 – низкодифференцированная аденокарцинома с прорастанием поджелудочной железы. в лимфатических узлах метастазы не обнаружены. В послеоперационном периоде отмечено повышение билирубина в крови до 120 ммоль/л, появилась желтушность кожи и склер.

С диагнозом структура печеночного протока больная 08.10.02 г. повторно взята на операцию.

Релапаротомия и ревизия брюшной полости обнаружена инфильтрация печеночной связки и умеренное расширение

холедоха. Лагатура наложенная на культю холедоха расшита и при этом выделился желчь с напряжением. При дальнейшей ревизии обнаружена перетяжка пузырного протока спайкой, спайка рассечена и через культю в желчный проток введен дренаж Д – 0,2 см. и установлен наружный дренаж. Состояние больной нормализовалось и в удовлетворительном состоянии выписалась 30 октября 2002 г.

Обсуждение

Таким образом, проведенный анализ работы показывает, что при правильной выработке показаний к хирургическому вмешательству, усовершенствовании техники исполнения операции можно достичь определенного успеха в снижении послеоперационной летальности. Одним из основных причин летальности является недостаточность швов панкреатоеюнального анастомоза.

Разработанный в клинике Карагандинского областного онкологического центра инвагинационный панкреатоеюнальный анастомоз дает возможность уменьшить количество такого грозного осложнения как недостаточность швов панкреатоеюнального анастомоза.

Литература

1. Whipple A. Surgical treatment of carcinoma of the ampullary region and head of the pancreas //Amer. J. of Surg., 1938. 40.1 p. 260-283.
2. Whipple A. Excision of the head of the pancreas //Lancet. 1996. 6421-6430/
3. Макоха Н.С. – В. кн.: Заболевания печеночных желчных ходов и травма живота. Киев «Здоровье», 1979. с. 171-172.
4. Cbatelani D., Flejou J.F. Pancreatectomy for adenocarcinoma: prognostic factors, recommendations for pathological reports //Ann. Pathol., 2002, 4.22, №5. p. 422-431
5. Хирургическое лечение злокачественных новообразований панкреатодуоденальной зоны //Шалимов А.А., Шалимов С.А., Земсков В.С. и др. – Вестник хир. 1978. 7. с. 6-11.
6. Фурторян Ч.С., Шубин Б.М. О выборе метода лечения при раке панкреатодуоденальной зоны //Вопросы онкологии, 1971. 6 с. 90-97.
7. Carcinoma of the body and the tail of the pancreas: is curative resection justified? //Dalton R.R., Saar M.G., van Heerden J.A. et al. – Surgery, 1992, v. III. p. 489-494.
8. Feduska J.J., Dent T.L., Lindenans S.M., Results of papillatome operation for carcinoma of the pancreas //Arch. surg., 1971, v. 103. p. 330-334.
9. Ryan D.P., Willet C.G. Management of locally advanced adenocarcinoma of the pancreas //Hematol. Oncol. Clin. North Amer., 2002, v. 16, №1. p. 95-103.
10. Trede M., Schwall A., Saeger H. Survival after pancreaticoduodenectomy: 118 consecutive resections without an operative mortality //Ann. Surg., 1990. 211:447-458.
11. Платюшко Ю.И., Котельников А.Г. Рак поджелудочной железы: диагностика и хирургическое лечение на современном этапе //Анналы хир. гепатологии, 1998, Т.3. №1. с. 96-111.
12. Расширенная панкреатодуоденальная резекция //Платюшко Ю.И., Котельников Е.Г., Соколова И.Н. и др. – Хирургия, 2000, 6. с. 4-6.
13. Small carcinoma of the pancreas. Factors of prognostic relevance //Brik D., Fortnagel G., Formentini A. et al. – Hepatobiliary Pancreatic Surg., 1998, 5. p. 450-454.
14. White T.T., Morgan A., Hopton D. Postoperative pancreatitis //Ann. J. Surg., 1970, v. 120. p. 132-133.
15. Гаврилин А.В., Вукотов А.В. Послеоперационные осложнения рака поджелудочной железы //Рак поджелудочной железы. М., 2003. с. 301-302.
16. Fortner J.G., Technique of regional subtotal and total pancreatectomy //Amer. J. Surg., 1985, v. 150, №5. p. 590-600.
17. Practical usefulness of lymphatic and connective Tissue Clearance for the carcinoma of the pancreas Head //Ishikawa O., Ohigashi H., Sasoci V.O. et al. – Amer. Surg. 1988, v. 208. p. 215-220.
18. Кубышкин В.А., Вишневецкий В.А. Заболеваемость. Этиологические предпосылки //Рак поджелудочной железы. Онкология, М. 2003. с. 13-15.
19. Surgical curability and prognosis for standard versus extended resections for T-1 carcinoma of the pancreas //Satake K., Nishiwaki H., Yokomatsu A. et al. – Surg. Gyn. Obst., 1992, 175: p. 259-265.